

Sinusitis

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Consenso de la SAP
Libro Azul de Infectología Pediátrica

Introducción

Los senos maxilares y etmoidales están completamente desarrollados al momento del nacimiento, los esfenoidales se desarrollan entre los 3 y 7 años y los frontales entre los 7 y los 12 años.

El seno etmoides es capaz de enfermar tempranamente y la etmoiditis del lactante se expresa como celulitis orbitaria.

Los senos maxilares aumentan progresivamente de volumen y en mayores de dos años pueden enfermar.

El seno frontal enferma en general alrededor de la pubertad (sinusitis muy rara).

La localización maxilar es la involucrada más frecuentemente (95%) y puede ser exclusiva. Los senos frontales se comprometen en el 35%; la asociación más frecuente es con el seno esfenoidal; la frontal se asocia más con el seno etmoidal.

Factores predisponentes

- Inmunodeficiencias.
- Alergia.
- Anormalidades mucociliares.
- Defectos anatómicos.
- Cuerpo extraño. Sonda nasogástrica.
- Adenoiditis crónica o hipertrofia adenoidea.
- Natación. Barotrauma.
- Enfermedad fibroquística de páncreas.
- Síndrome de Down.
- Síndrome de Kartagener.
- Infección vírica previa.

Tiempo de evolución

Aguda: evolución hasta 2 a 3 semanas.

Subagudas: 4 a 7 semanas.

Crónica: evolución mayor de 8 semanas.

Recidivante: reaparición de la sintomatología luego de la cuarta semana.

Agentes etiologicos

- Streptococcus pneumoniae 25-30%
- Haemophilus influenzae 15-20%
- Moraxella catharralis 0,4-6%
- Staphylococcus aureus alrededor del 4%.
- Estreptococo beta hemolítico grupo A. 2-5%
- Etiología vira: rinovirus, parainfluenza, influenza, adenovirus 15%

En las sinusitis crónicas se aíslan con mayor frecuencia agentes como Staphylococcus aureus 9%, anaerobios y Gram (-), siendo frecuente también la presencia de flora polimicrobiana.

Bacterias relacionadas al tipo de sinusitis

	Aguda	Subaguda	Crónica
S. pneumoniae	+	+	-
H. influenzae	+	+	-
M. catarralis	+	+	+
S. aureus	-	-	+
Anaerobios	-	-	+

Radiodiografía

- Frontonasoplaca
- Mentonasoplaca
- Lateral

Los estudios radiológicos son los más específicos y accesibles.

No se justifica su realización ante el primer episodio de sinusitis.

El seno maxilar puede visualizarse al año de vida, el esfenoidal se visualiza al año y medio y los senos frontales a partir de los 2 años.

Se toma como patológico:

- El engrosamiento de la mucosa mayor del 50%
- Compromiso unilateral
- La presencia de niveles hidroaéreos
- Opacidad de algunos de los senos

En niños menores de 1 año es muy difícil interpretar los hallazgos radiológicos, por lo cual no se justifica su realización.

TAC: Útil para la evaluación de los senos etmoidales y esfenoidales, inaccesibles a la radiografía simple.

Tratamiento antibióticos

1a. elección: amoxicilina a 90 mg/kg/día durante 2 a 3 semanas.

En áreas donde predominen cepas productoras de Beta lactamasas: amoxicilina clavulanato.

Criterios de indicación

- Síntomas persistentes: rinorrea de cualquier tipo o tos que persiste por más de 10 días sin evidencia de mejoría.
- Síntomas de empeoramiento: rinorrea o tos que se agrava a partir del 6º día, con reaparición de la fiebre o incremento de la tos o rinorrea después de una mejoría transitoria.
- Síntomas graves: Fiebre $\geq 39^{\circ}\text{C}$ y rinorrea espesa amarillo-verdosa concomitante, durante por lo menos 3 días consecutivos.

Tratamiento sintomático

Solución salina hipertónica

Los descongestivos y antihistamínicos no han sido lo suficientemente estudiados como para determinar su utilidad.

Las gotas nasales están contraindicadas (nafazolina por ejemplo)

Quirúrgico

Lavados, drenajes.

Se plantea ante una mala evolución del proceso infeccioso, la sospecha de enfermedad tumoral, micótica, abscesos, osteomielitis, pacientes inmunosuprimidos. En este último grupo es importante el aislamiento de gérmenes como así también el drenaje de un foco supurado.

Complicaciones

Se observan complicaciones en un 4-5% de los pacientes con sinusitis. Ellas son:

- Sepsis
- Abscesos epidurales y subdurales.
- Osteomielitis.
- Meningitis.
- Celulitis periorbitaria.

En estas situaciones el paciente deberá ser internado para un mejor control, adecuado tratamiento médico y eventual tratamiento quirúrgico.

Medidas de control y prevención

Eliminar tabaquismo pasivo

En niños con sinusitis activa o episodios muy frecuentes evitar la inmersión en piletas.